Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0002869-39.2025.8.17.4001**

AUTOR(A): KEILA GARCIA CHAGAS

RÉU: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ONCOLÓGICO (CLEXANE). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

- A operadora de autogestão em saúde não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não oncológico que não conste do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.

- A recusa fundamentada em exclusão contratual legítima e respaldada por norma legal e regulamentar não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

Vistos etc.

KEILA GARCIA CHAGAS, qualificada nos autos, ingressou com **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral** em face de **PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A**, igualmente identificada.

Expôs a autora ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré e encontrar-se em sua décima semana de gestação, classificada como de alto risco, sendo portadora de trombofilia (mutação do gene MTHFR), com histórico de perda fetal intrauterina em 2021 (natimorto com 39 semanas).

Narrou que, diante desse quadro clínico, a médica hematologista que a acompanha, Dra. Danielle Padilha de Oliveira (CRM/PE 13336), prescreveu o uso contínuo do medicamento **CLEXANE (enoxaparina sódica) 40mg/dia**, durante todo o período gestacional e no puerpério, como medida indispensável para evitar complicações graves, como trombose placentária, aborto e morte fetal.

Apontou que, ao solicitar a autorização e o custeio do fármaco à ré, teve seu pedido negado administrativamente, sob a justificativa genérica de "ausência de cobertura contratual" e "serviço solicitado fora de cobertura".

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito, sob pena de multa diária, e, ao final, a condenação por indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo Plantonista em 23/06/2025, determinando que a ré autorize e custeie o medicamento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (id 208096303).

Os autos foram distribuídos a esta Vara.

Ordem de emenda para: "a*) acostar cópia do instrumento de contrato firmado com a demandada de forma legível, eis que imprescindível que seja especificado e provado qual o tipo de pacto firmado e as suas condições; b) esclarecer o conteúdo do documento de id 208091181, pág. 02 em que consta: "Beneficiário está com apólice suspensa desde 05/05/2025"; c) especificar o pedido, quantificando o tratamento pretendido, com valores, inclusive, para atender ao art. 322 do CPC; d) atribuir à causa o valor de acordo com o disposto no art. 292, VI, do CPC (art. 259, II, do CPC/73), diante da cumulação de pedidos; e) trazer aos autos comprovante de rendimentos mensais atualizados, extratos de cartão de crédito, declaração de bens, cópia do imposto de renda e fatura de energia elétrica e água, nos moldes do art. 99, §2, do CPC, após o que apreciarei o pleito de gratuidade da justiça ou quitar custas"*.

Emenda da inicial para esclarecimentos solicitados.

Despacho (id 210546243).

Decisão que tronou sem efeito a decisão de id 210546243, porque foi aposta em processo equivocado, retificou o valor da causa para R$ 33.067,78 e cassou a decisão de id 208096303 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 214901882).

A Autora interpôs Agravo de Instrumento (Id. 215622174) contra o indeferimento da gratuidade, e juntou o protocolo do recurso aos autos (Id. 215622172).

O Réu foi citado e intimado (Id. 216433382 e 216433383), apresentando Contestação (Id. 219748746 e 219748747), alegando, em síntese, a ausência de previsão contratual e legal de cobertura para medicamento domiciliar (art. 10, VI, Lei nº 9.656/98$), a licitude da negativa e a taxatividade do Rol da ANS (EResp nº 1.886.929/SP).

Defendeu, ainda, a inexistência de Danos Morais por ser a recusa um exercício regular de direito e mero dissabor.

Intimada para réplica, a Autora apresentou manifestação (Id. 222256727), reiterando os termos da inicial e requerendo o julgamento antecipado da lide. Informou, ainda, o descumprimento da liminar pelo Réu, com a posse de apenas 2 seringas, e pediu intimação imediata para fornecimento.

O Réu peticionou (Id. 222881876) para juntar provas supervenientes, alegando que a Autora não ficou desassistida (pois autorizou medicamentos oncológicos), e reiterou a tese de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, concordando com o imediato julgamento da lide. Juntou guias de autorização de medicamentos (CLEXANE) com datas de 05/09/2025 e 09/11/2025 (Id. 222884832 e 222884833).

É o relatório, passo à decisão.

JULGAMENTO

Analisando os autos, verifico haver elementos suficientes à apreciação de mérito. Assim, rejeito a prova requerida pela parte ré, o que faço lastrada no entendimento de que o magistrado que preside também orienta a produção probatória e lhe cabe indeferir provas que não sirvam ao desfecho da lide.

Ressalto que a questão da **Gratuidade de Justiça**, indeferida na decisão de Id. 214901882 e objeto do Agravo de Instrumento (Id. 215622174), não obsta o julgamento do mérito, cabendo à instância superior decidir sobre o tema.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 7.265

O Supremo Tribunal Federal (STF), em 18/09/2025, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 7.265, conferindo interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº. 9.656/1998, incluído pela Lei nº. 14.454/2022, sobre a taxatividade do chamado rol da ANS, relação de procedimentos e eventos em saúde que as operadoras de saúde suplementar são obrigadas a oferecer, conforme cada tipo de plano de saúde.

O julgado fixou critérios objetivos a serem necessariamente observados para que ocorra a excepcionalização da taxatividade da referida relação, uniformizando os parâmetros técnicos e jurídicos a balizarem a atividade judicial na apreciação de pedidos de cobertura de procedimentos não listados como obrigatórios, e, ainda, a imprescindibilidade de prova, pelo solicitante, de que a operadora negou o tratamento, demorou excessivamente ou se omitiu em responder, sob pena de nulidade da decisão.

A Corte Suprema fixou a seguinte tese:

> "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
>
> 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
>
> (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
>
> (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
>
> (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
>
> (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

Os critérios definidos no julgamento da ADI nº. 7.265, inclusive, basearam-se nas teses de repercussão geral fixadas pelos também recentes Temas 1234 e 6 do STF, que esclareceram conceitos e princípios aplicáveis ao direito sanitário, sendo assim reforçada a necessidade de uniformidade e coerência no tratamento das questões relativas à assistência à saúde nos sistemas público e privado, postas à decisão nos tribunais estaduais, federais e superiores.

LIDE

O pedido foi de fornecimento de medicamento, cabendo ser observado que mesmo o plano de referência não possui tal cobertura, havendo exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS. Assim o art. 10 da lei 9.656/98:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) *(Vigência)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente."

Algumas dessas exceções constam do inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021:

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
Parágrafo único. <u>São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:</u>
(...)
VI - <u>fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar</u>, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

O PARECER TÉCNICO Nº 20/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024[1] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Clexane.docx#_ftn1), que trata dos medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, diz ser obrigatória a cobertura para:

"a) medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e

b) medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021; e

c) medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes."

No presente caso, <u>não</u> **se trata de pedido de fornecimento de medicação oncológica domiciliar nem de negativa de um exame ou de um tratamento hospitalar**, mas da medicação hormônio do crescimento (GH - Somatropina), nas apresentações **CLEXANE (enoxaparina sódica) 40mg/dia**, para tratamento de trombofilia (mutação do gene MTHFR), conforme laudo de id 208091179, a ser tomada em forma de injeção subcutânea no domicílio, não estando coberto pelo contrato firmado e nem constando no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS (RN nº 465/2021), pelo que descabe cobertura, pois não resta obrigatório seu fornecimento pelo plano de saúde.

Assim, o medicamento CLEXANE (enoxaparina sódica) é de uso domiciliar, a paciente não é oncológica e não está em tratamento domiciliar (*home care*).

Trago à luz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)"* (grifos para destacar)
>
> *"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE S AÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA COMO NEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2031280 MG 2022/0317722-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)"* (grifos para destacar)

Incluo julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco no mesmo sentido de ausência do dever de cobertura de medicamentos domiciliares não oncológicos pela operadora de saúde suplementar:

> *"PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autora portadora de trombocitopenia imune (PTI), sendo-lhe prescrito tratamento com uso contínuo do medicamento Revolade 50mg. 2. Medicamento de uso domiciliar; lícita a conduta do plano de saúde que se recusa a custear medicamento expressamente excluído*

da cobertura. 3. Obrigar as seguradoras a cobrir os medicamentos de uso domiciliar prescritos pelos médicos assistentes resultaria em significativo aumento dos custos, e, sem o aumento da contraprestação, se estaria a lesionar a comutatividade e o equilíbrio contratual. 4. O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 possibilita às operadoras restringirem o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, razão pela qual a limitação está em consonância com a legislação pertinente e não se mostra abusiva frente aos princípios e normas que regem os direitos do consumidor. 5. Destaque-se que não se está diante de negativa de medicamento substituto das internações hospitalares ou ambulatoriais para sessões de quimioterapia, isso porque os medicamentos utilizados em concomitância com a quimioterapia e radioterapia não se inserem na regra de exclusão do artigo 10, VI, da lei 9656/98, que permite a exclusão contratual do fornecimento de medicação domiciliar. 6. O medicamento requerido não se encaixa em nenhuma das hipóteses de cobertura previstas na Lei n. 9.656/1998, não havendo, bem por isso, obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. 7. Sentença reformada. 8. Provimento do recurso. (TJ-PE - AC: 00007095520228172640, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC))" (grifos para destacar)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MONITOR E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ÍNDICES GLICÊMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O cerne da demanda consiste em averiguar o dever da Agravada em custear o tratamento perseguido nos autos - monitor e sensor contínuo de glicemia (FREESTYLE LIBRE). - Conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98 e precedentes do c. STJ, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados (arts. 10, VI e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98). - Portanto, encontram-se excluídos da cobertura pelos planos de saúde aquelas medicações/insumos adquiridos facilmente em farmácias e cuja aplicação (uso) pode se dar no âmbito domiciliar (Precedentes c. STJ). - Do mesmo modo, diante da desnecessidade de intervenção médico-cirúrgicas relacionadas ao fornecimento do aparelho, encontram-se excluídos da cobertura obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 10, VII, da Lei de regência. - Recurso desprovido. (TJ-PE - AI: 00166532920228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)" (grifos para destacar)"

"PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AFASTAR JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E PRELIMINAR DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS REJEITADA. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENA. ESQUIZOFRENIA CRONICA. NEGATIVA. DOMICILIAR (NENHUMA HIPOTESE DO ARTIGO art. 10,VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998. FÁRMACO QUE NÃO SE RELACIONA A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO, NEM DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. EXCLUSÃO ANS. ROL TAXATIVO. RECUSO DA RÉ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. Precedentes STJ. 2. In casu, EMBORA comprovada a necessidade de a paciente utilizar o medicamento solicitado como única terapia disponível, o Plano de Saúde não possui o dever de custear o medicamento de uso domiciliar (Invega Sustenna), pois extrapolaria os limites contratuais e legais, 3. Dado o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em R$ 500,00. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 00702011920198172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))" (grifos para destacar)"

Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador adversário, com base no art. 85, § 2º, do CPC, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e suspensos até julgamento do Agravo de Instrumento (Id. 215622174).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 12 de novembro de 2025.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20%20Clexane.docx#_ftnref1) Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-20_2024_medicamentos-para-tratamento-domiciliar.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-20_2024_medicamentos-para-tratamento-domiciliar.pdf)> ACESSO EM 17/03/2025.

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
14/11/2025 13:05:38
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 223155529

25111413053865400000217151757

IMPRIMIR GERAR PDF